

【제 목】 : DUR대국민 교육 실효성 확보에 관한 방안마련 필요(권고)

【내 용】

- DUR관리실은 「의료법」 제18조의2 및 「약사법」 제23조의2에 따라 의약품 처방·조제시 의약품 안전성과 관련된 정보를 실시간으로 제공하여 국민에게 위해한 의약품을 사전에 점검할 수 있는 ‘의약품안전사용서비스(Drug Utilization Review, 이하 ‘DUR’이라 한다.) 업무를 담당하고 있다.
- 안전하고 적절한 의약품 사용을 유도하여 올바른 의약품 사용 문화를 확산하고자 의료소비자인 국민을 대상으로 한 교육을 【표 4】 ‘대국민 DUR교육 현황’에서와 같이 실시하고 있으며,

【표 4】 대국민 DUR교육 현황 (2015~2017)

연도	기간	횟수	교육대상인원	소요예산
2015	*월 ~ **월	**회	*****명	*****원
2016	*월 ~ **월	**회	*****명	*****원
2017	*월 ~ **월	**회	*****명	*****원

주. 소요예산: 강사료, 기념품, 교재 등

- 대국민 DUR교육은 DUR에 대한 국민 인지도 제고(‘16년 **.*% → ‘17년 **.*%), 교육 후 이해도 상승 (‘17년 기준 교육 전보다 **.*%p상승) 등의 긍정적인 효과를 나타내고 있다.

- 이에, 감사일 현재까지 대국민 DUR교육 현황을 점검한 결과,

가. 대국민DUR교육의 교육대상자 다각화 필요

- 【표 5】 ‘대국민 DUR교육 대상자 현황(2015-2017)’에서와 같이 교육 대상자를 의약품의 복용빈도가 높고 관심이 많은 성인, 노인 위주로 확대하고자 노력하고 있다.
- 다만, ‘17.8월 기준 DUR점검항목별 대상의약품 중 전체의 약 30%를 차지(※성분수 기준 ***개, 동일성분 중복은 제외)하는 ‘임부금기’의 대상자인 임부에게 제공되는 교육의 기회는 미흡한 실정으로,
 - 의약품 사용이 태아의 건강과 직결되어 자발적, 적극적으로 교육에 참여할 가능성이 높아 긍정적 교육효과가 예상되는 집단인 임부를 교육 대상으로 확대하는 방안 마련이 필요하다.

【표 5】 대국민 DUR교육 대상자 현황 (2015~2017)

(단위: 명, %)

연도	합계	노인	성인	학생 (초,중,고)
2015	***** (100.0)	*** (*.*)	*** (*.*)	***** (*.*)
2016	***** (100.0)	*** (*.*)	*** (*.*)	***** (*.*)
2017	***** (100.0)	*** (*.*)	*** (*.*)	***** (*.*)
합계	***** (100.0)	*** (*.*)	*** (*.*)	***** (*.*)

☞ 참고자료 : 【국민대상 DUR 교육결과보고, 2015,2016,2017】

<2015 국민대상 DUR교육결과 보고, DRU관리부-279, 2016.02.11.>

○ 4. 향후 교육 계획

- 한국소비자단체협회와 연계하여 노년층 교육 확대 실시

<2016년 대국민 DUR교육결과 보고, DRU관리부-2798, 2016.10.19.>

○ 5. 향후 교육 계획

- 성인 및 노인층 교육 지속적 확대

· 한국소비자단체, 마약퇴치운동(광주,전남) 등 성인대상교육 기관의 교육 횟수 확대 실시로 교육 효과 증대

<2017년 대국민 교육 결과 보고, DRU관리부-2356, 2017.12.29.>

○ 5. 향후 교육 계획

- 교육대상 확대 및 교육방식 다양화로 위탁교육 의존 탈피

· (의료소비자) 교육대상자의 산재(학생, 어르신 등)

→ 안전한 의약품 사용 문화 조성을 위한 교육의 효과, 필요성 등을 고려하여 성인대상 교육 지속적 확대 · 집중

나. 대국민DUR교육제공 지역의 다양화 필요

- DUR실에서는 【표 6】 ‘대국민 DUR교육제공 지역 현황(2015-2017)’에서와 같이 교육실시 지역이 서울에 편중되어 있는 점을 개선하고자 2016년부터 강원, 광주, 충북으로 확대하고 있으나 그 비율이 미미한 실정이다.
- 【표 7】 ‘ 시도별 원외처방횟수(2015-2017)’에서와 같이 지역이 넓고 의료기관수가 많은 등의 사유로 원외처방횟수가 많아 DUR점검 가능성이 높은 경기, 부산, 경남지역은 교육이 제공되지 않아 의료서비스 이용현황을 반영한 실질적인 교육체계 방안 마련이 필요하다.

【표 6】 대국민 DUR교육제공 지역 현황(2015~2017)

(단위: 명, 회, %)

구분	2015		2016		2017	
	대상자수	횟수	대상자수	횟수	대상자수	횟수
서울	***** (**, *)	** (**, *)	***** (**, *)	** (**, *)	***** (**, *)	** (**, *)
대구	***** (**, *)	** (**, *)	***** (**, *)	** (**, *)	***** (**, *)	** (**, *)
강원	-	-	*** (*, *)	** (**, *)	*** (*, *)	** (**, *)
광주	-	-	*** (*, *)	* (*, *)	** (*, *)	* (*, *)
충북	-	-	-	-	*** (*, *)	* (*, *)

【표 7】 시도별 원외처방횟수 (2015~2017)

(단위: 천건, 회, %)

시도	2015		2016		2017	
	횟수	비율	횟수	비율	횟수	비율
서울	*****	** , *	*****	** , *	*****	** , *
경기	*****	** , *	*****	** , *	*****	** , *
부산	*****	*, *	*****	*, *	*****	*, *
경남	*****	*, *	*****	*, *	*****	*, *
대구	*****	*, *	*****	*, *	*****	*, *
인천	*****	*, *	*****	*, *	*****	*, *
경북	*****	*, *	*****	*, *	*****	*, *
·	·	·	·	·	·	·

주1. 건강보험심사평가원 연도별 진료비통계지표, 건강보험 및 의료급여

주2. 의료기관의 입원, 외래에서 발행된 원외처방 횟수(약국제외)

【조치할 사항】

- ① 교육대상자를 임부로 확대하는 등 교육 대상을 다각화하고,
- ② 의료서비스 이용 현황 등의 지역 특성을 반영하여 교육대상 지역을 선정하는 등의 대국민 DUR교육의 실효성 확보 방안을 마련하시기 바랍니다.